

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ

Γενικά: Ως κυτταρίτιδα οφθαλμικού κόγχου (ΚΟΚ) χαρακτηρίζεται η φλεγμονή των ιστών που βρίσκονται πέριξ και οπισθίως του οφθαλμικού βολβού. Πρόκειται για σοβαρή κλινική οντότητα, με σημαντική νοσηρότητα, λόγω του κινδύνου επιπλοκών από το ΚΝΣ και ως εκ τούτου η έγκαιρη διάγνωσή της και η ταχεία θεραπεία της, είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Η ΚΟΚ αφορά όλες τις ηλικίες, αλλά 70% των περιπτώσεων αφορά παιδιά < 10 ετών.

Ο συνηθέστερος μικροβιακός παράγων στη ΚΟΚ σε παιδιά είναι ο *S. pneumoniae* και ακολουθούν οι *S. aureus*, *S. pyogenes*, *M. catarrhalis*, ενώ λοίμωξη από *H. influenzae* type B είναι πλέον σπάνια, λόγω του εμβολιασμού. Αναερόβια μη σπορογόνα βακτήρια, όπως στελέχη *Peptostreptococcus*, *Peptococcus* και *Bacteroides*, είναι λιγότερο κοινά αίτια και σχετίζονται με λοιμώξεις μετά από δήγματα ανθρώπων ή ζώων. Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς η ΚΟΚ μπορεί να οφείλεται σε είδη μυκήτων, όπως *Mucor* και *Aspergillus*.

Η συχνότερη αιτία (75-85%) της ΚΟΚ είναι η δευτερογενής επέκταση της λοίμωξης από τους παραρρινίους κόλπους και ιδιαιτέρως από τους ηθμοειδείς κόλπους, δεδομένου των λεπτών κογχικών τοιχωμάτων. Άλλες αξιοσημείωτες αιτίες της ΚΟΚ, περιλαμβάνουν, τραύμα με σχετικό κάταγμα κόγχου ή βάσης του κρανίου, ξένο σώμα, δακρυοκυστίτιδα (απόφραξη ρινοδακρυϊκού πόρου), οδοντικές λοιμώξεις, ενδοφθαλμίτιδα μη θεραπευθείσα βλεφαρίτιδα και άσθμα. Η ΚΟΚ είναι σπάνια μετά από οφθαλμική χειρουργική επέμβαση, αλλά έχει αναφερθεί μετά από χειρουργική επέμβαση στραβισμού, χειρουργική επέμβαση βλεφάρων, χειρουργική του εμπρόσθιου τμήματος του οφθαλμού και περιβολβική ένεση.

Κλινική εικόνα: Η ΚΟΚ, στα αρχικά της στάδια, χαρακτηρίζεται από διάχυτο οίδημα και φλεγμονή του κογχικού λίπους, που προκαλεί οίδημα κι ερυθρότητα των βλεφάρων και μεγάλη ευαισθησία του οφθαλμικού βολβού στη ψηλάφηση, χωρίς διαταραχές της όρασης και της κινητικότητας του οφθαλμού. Κατά την πορεία της νόσου μπορεί να παρουσιαστεί σοβαρό οίδημα των βλεφάρων και περικογχικά, μείωση όρασης, πόνος στην κίνηση των οφθαλμών, πρόπτωση, οφθαλμοπληγία και γενικά συμπτώματα, όπως κακουχία, πυρετός, κεφαλαλγία και ανορεξία. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το χαλάζιο, το ερυσίπελας, το αγγειοοίδημα, την οστεομυελίτιδα, τη θυρεοειδοπάθεια και το νυγμό εντόμων.

Θεραπευτική παρέμβαση

Ασθενείς με ελαφράς βαρύτητας ΚΟΚ και χωρίς επιπλοκές ή άλλα σοβαρά νοσήματα, μπορούν να λάβουν από του στόματος αντιβιοτική θεραπεία κατ' οίκον. Η αγωγή μπορεί να ξεκινήσει και ΕΦ, με παραμονή σε Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και με τη βελτίωση της κλινικής εικόνας να μετατραπεί σε *per os*, εντός 48-72 ωρών. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας υποδηλώνεται από την εμφάνιση απυρεξίας και την κλινική βελτίωση μετά από 48-72 ώρες θεραπείας. Η διάρκεια της αντιβιοτικής θεραπείας κυμαίνεται τουλάχιστον σε 2-3 εβδομάδες. Ασθενείς με μέτρια ή βαριά ΚΟΚ, καθώς και με ηθμοειδίτιδα ή με οστική βλάβη των παραρρινίων, απαιτούν νοσηλεία και θεραπεία τουλάχιστον 4 εβδομάδων.

1. Ξεκινάμε εμπειρικά, με Βανκομυκίνη (για MRSA) και Μετρονιδαζόλη, καθώς και ένα εκ των Κεφτριαξόνη / Κεφοταξίμη / Αμικιλλίνη-Σουλμπακτάμη, για 48-72 ώρες. Π.χ:
 - **Voncon:** 2 amp. 500 mg, σε 100 ml N/S, ανά 8ωρο. (Παιδιά: 10-20 mg/kg/6-8 ώρες).
 - **Flagyl** ή **Colpocin-T:** 1 vial. 500 mg/100 ml 1x3 (iv), ή 1 tab. 500 mg 1x3 *per os*. (Παιδιά: 30 mg/kg/24h iv ή po, ή αλλιώς 7-8 mg/kg ανά δόση, κάθε 6 ώρες).
 - **Rocephin/Veracol:** 1 amp. 2 gr 1x1, ή και 1x2 εφόσον υπάρχει σοβαρή λοίμωξη. (Παιδιά: 50 mg/kg 1 ή 2 φορές την ημέρα, iv ή im. Μέγιστη δόση: 4 gr ανά 24ωρο).
 - **Claforan:** 2 vials του 1 gr, ανά 4-6 ώρες, σε iv έγχυση ή im ένεση. (Παιδιά: 150-200 mg/kg/24h, σε 3 διηρημένες δόσεις. Μέγιστη ημερήσια δόση: 12 gr).
 - **Begalin:** 1 vial 3 gr ανά 6ωρο. (Παιδιά: 75 mg/kg, ανά 8ωρο. Μέγιστο 12 gr/24ωρο).
2. Μετά τη διάγνωση και την αρχική θεραπεία ή επί επιπλοκών, διακομίζουμε σε κλινική.